

Doença de Still do Adulto

Vamos começar nossa discussão de hoje com um caso clínico bem interessante que ilustra perfeitamente as características da **doença de Still**. Imagine uma menina de 5 anos que chega na UPA com história de dor no joelho esquerdo, aumento de volume e limitação dos movimentos, principalmente pela manhã ao acordar. Esse quadro começou há dois meses, sem nenhum trauma aparente, e foi evoluindo progressivamente para acometer o ombro esquerdo, depois o joelho direito e os quadris bilateralmente. Perceba que estamos diante de uma **poliartrite migratória** aqui.

Há cerca de 15 dias, os punhos também foram envolvidos com as mesmas características inflamatórias, mas agora com um diferencial importante: a paciente começou a apresentar **febre e exantema**. Outro detalhe que não pode passar despercebido é que ela queixa de dor ocular que piora com luz forte, mantendo os olhos permanentemente vermelhos, além de dor ao mastigar e abrir a boca, sugerindo acometimento da articulação temporomandibular.

No exame físico, encontramos **hiperemia ocular**, temperatura de 38°C, e aqui vem um achado fundamental: um **exantema cor de salmão** localizado principalmente em axilas e zonas de pressão. Há também discreta hepatoesplenomegalia, linfonodos sem características patológicas, e nas articulações acometidas observamos a tríade inflamatória clássica de edema, calor e redução da amplitude de movimento. Laboratorialmente, o hemograma mostra **leucocitose de 15.000** às custas de neutrófilos, com plaquetas em 400.000.

Agora vamos entender melhor o que é essa entidade. A **doença de Still** é uma síndrome inflamatória rara causada por uma **desregulação do sistema imune inato**. Aqui vai um conceito moderno e importante que cai muito em prova: atualmente, a doença de Still é entendida como uma entidade única, independente da idade de acometimento. Antigamente, havia uma separação artificial baseada na faixa etária:

quando as manifestações ocorriam em crianças, chamávamos de **AIJ sistêmica** (artrite idiopática juvenil sistêmica), e quando acometia adultos, denominávamos **doença de Still do adulto**. Essa nomenclatura dupla está sendo abandonada progressivamente.

A apresentação clínica característica da doença de Still forma uma tríade que você precisa memorizar: **febre diária elevada (geralmente acima de 39°C), artrite e rash cutâneo tipo salmão**. Vamos detalhar cada componente dessa tríade.

A febre tem um padrão muito característico que as bancas adoram cobrar. Ela ocorre em **picos durante o dia**, alternando momentos de temperatura normal com momentos de hipertermia significativa. Não é uma febre contínua, nem irregular com dias sem febre. É uma febre cotidiana, alta, em espículas, que vai e volta. Pegadinha de prova: se você vir alternativas descrevendo febre contínua com prostração intensa ou febre irregular com variações de horários, pode eliminar de cara.

O **rash cutâneo cor de salmão** é outro achado patognomônico. Esse exantema é transitório e tem uma característica peculiar: ele costuma aparecer justamente nos **momentos de pico febril**. Então, quando o paciente está com febre alta, o rash se manifesta, e quando a temperatura normaliza, ele some. Localização preferencial? Axilas e zonas de pressão, exatamente como descrito no nosso caso clínico.

Laboratorialmente, além da leucocitose neutrofílica e do aumento de plaquetas que já mencionamos, o grande marcador é a **hiperferritinemia**. A ferritina está muito elevada nesses pacientes, e esse é um achado que ajuda bastante no diagnóstico diferencial. As provas de atividade inflamatória também estão aumentadas, especialmente a **PCR**.

Outros sinais e sintomas que podem aparecer incluem **serosite** (pericardite, pleurite), **hepatoesplenomegalia**, **mialgia**, **dor abdominal** e **linfonodomegalias**. No caso da nossa paciente pediátrica, temos ainda manifestações oculares (uveítes são mais comuns nas AIJs) e acometimento da ATM, explicando a dor ao mastigar e abrir a boca.

Vamos falar agora sobre o tratamento, que é uma parte crucial. O pilar terapêutico são os **glicocorticoides**. Geralmente iniciamos com um **pulso de metilprednisolona** para controlar rapidamente a atividade inflamatória. Mas como sabemos que o uso prolongado de corticoide traz uma série de complicações, sempre associamos um **medicamento poupador de corticoide**.

As opções disponíveis incluem a **ciclosporina**, que é um imunossupressor mais clássico. Temos também os biológicos modernos: o **tocilizumabe**, que é um **anti-IL-6** (anti-interleucina 6), e o **anakinra**, que é um **anti-IL-1** (anti-interleucina 1). Vale ressaltar que o anakinra ainda não é amplamente disponível no Brasil, mas é uma opção terapêutica muito eficaz em outros países.

Comentário crítico aqui: a escolha do imunobiológico faz todo sentido quando entendemos a fisiopatologia. A doença de Still tem participação importante de citocinas pró-inflamatórias, especialmente IL-1 e IL-6, então bloquear essas vias é extremamente racional do ponto de vista terapêutico.

Agora vamos amarrar o caso clínico com os conceitos discutidos. Estamos diante de uma menina de 5 anos, portanto, numa apresentação pediátrica que antigamente chamávamos de AIJ sistêmica. Ela tem todos os elementos diagnósticos: quadro articular franco de artrite ao exame físico, rash cutâneo cor de salmão, febre característica, hepatoesplenomegalia e leucocitose. As manifestações oculares (uveíte) e o acometimento da ATM são mais típicos das apresentações pediátricas.

Pegadinha de prova que caiu no SUS Bahia 2023: considerando a febre que usualmente acompanha quadros semelhantes à doença de Still, qual seria o padrão correto? As alternativas eram: febre elevada e contínua com prostração intensa; contínua e baixa associada à cefaleia; irregular com variações de horários e dias sem febre; ou diária e elevada em picos com retorno à temperatura normal.

A resposta correta é a última: **febre diária, elevada em picos, com retorno à temperatura normal**. Essa é uma característica marcante. Febre alta (geralmente acima de 39°C), cotidiana, em espículas, alternando com momentos de apirexia. E é justamente durante os picos febris que o rash salmão se manifesta.

Por último, um gancho importante para aulas futuras: qual seria a **complicação mais grave** da doença de Still ou AIJ sistêmica? A resposta é a **síndrome de ativação macrofágica** (SAM). Essa é uma complicação potencialmente fatal que merece atenção especial e será discutida detalhadamente na aula de reumatologia pediátrica. Fique atento a esse conceito porque ele é cobrado frequentemente em provas de residência.

Mnemônico para fixar a tríade da doença de Still: **FAR** - Febre (diária em picos), Artrite, Rash (salmão transitório). Sempre que você vir esse FAR associado à hiperferritinemia, pense na doença de Still.

Resumindo os pontos essenciais: a doença de Still é uma entidade única de desregulação imune inata que se manifesta com febre diária em picos, artrite, rash salmão transitório e hiperferritinemia. O tratamento envolve glicocorticoides mais poupadores como ciclosporina ou biológicos (tocilizumabe, anakinra). A complicação mais temível é a síndrome de ativação macrofágica. Esses são os pilares conceituais que você precisa dominar sobre essa doença para arrasar nas provas de residência.